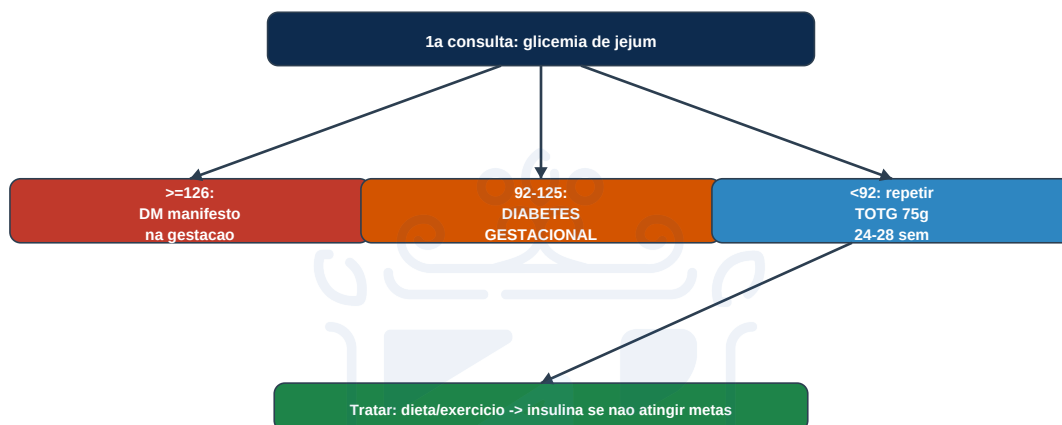


DIABETES GESTACIONAL — DIAGNÓSTICO E METAS

FLUXOGRAMA — RASTREAMENTO

DG — GLICEMIA NA 1a CONSULTA, TOTG 24-28 SEM



DEFINIÇÃO E IMPACTO

O QUE É

- Hiperglicemia diagnosticada pela 1ª vez na gestação que NÃO preenche critérios de DM prévio
- DM manifesto na gestação: critérios de DM fora da gestação (jejum ≥ 126 , HbA1c $\geq 6,5\%$, casual ≥ 200 com sintomas)
- Fisiopatologia: resistência insulínica por hormônios placentários + falha da célula beta
- Impacto materno: pré-eclâmpsia, polidrâmnio, mais cesárea | fetal: MACROSSOMIA, distócia de ombro, hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia

DIAGNÓSTICO — GLICEMIA DE JEJUM E TOTG 75g

Exame	Valor	Interpretação
Jejum (1a consulta)	≥ 126 mg/dL	DM manifesto na gestação
Jejum (1a consulta)	92-125 mg/dL	Diabetes gestacional
Jejum (1a consulta)	< 92 mg/dL	Repetir com TOTG 75g entre 24-28 sem
TOTG 75g (24-28 sem)	Jejum ≥ 92 / 1h ≥ 180 / 2h ≥ 153	1 valor alterado = DG (IADPSG/ADA)

METAS GLICÊMICAS (SBD/ADA)

CONTROLE

- Jejum < 95 mg/dL
- 1h pós-prandial < 140 mg/dL (OU 2h pós-prandial < 120 mg/dL)
- Monitorização: 4-7 medidas/dia (jejum + pós-prandiais)
- Avaliação fetal: USG para biometria (atenção à circunferência abdominal) e líquido amniótico
- Controle do ganho ponderal conforme IMC pré-gestacional

TRATAMENTO — NÃO FARMACOLÓGICO (1a LINHA)

Rx DIETA + EXERCÍCIO

Plano alimentar individualizado: 35-45% de carboidratos (baixo índice glicêmico)
Fracionamento: 3 refeições + 2-3 lanches; evitar cetose (não restringir CHO em excesso)
Proteína ~1,1 g/kg/dia; controle do ganho ponderal conforme IMC
Atividade física: 150 min/semana de intensidade moderada
Caminhada pós-prandial melhora o pico glicêmico

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

Rx SE 1-2 SEMANAS DE DIETA NÃO ATINGEM METAS

INSULINA = padrão-ouro (NÃO atravessa a placenta): NPH + regular ou análogos (detemir, lispro, aspart — seguros)
Dose inicial 0,7-1,0 UI/kg/dia (aumenta progressivamente no 3o trimestre)
Hiperglicemia isolada de jejum -> NPH noturna; picos pós-prandiais -> ultrarrápida pré-refeição; basal-bolus se necessário
Metformina: atravessa a placenta; menos ganho de peso e hipoglicemia; ~30-40% precisam de insulina complementar
Aceita (SBD/Febrasgo) se recusa à insulina ou casos selecionados

CONDUTA OBSTÉTRICA E PÓS-PARTO

RESOLUÇÃO E SEGUIMENTO

- USG seriada a cada 3-4 semanas se controle inadequado; perfil biofísico a partir de 32-34 sem se uso de insulina
- Indução: controle adequado sem complicações -> 39-40 sem; macrossomia/controle ruim -> considerar 38-39 sem
- Cesárea eletiva se peso fetal estimado ≥ 4.500 g (risco de distócia de ombro)
- PÓS-PARTO: suspender insulina imediatamente (na maioria); reavaliar com TOTG 75g em 6-12 semanas
- Risco futuro: 30-70% evoluem para DM2 em 10-20 anos -> controle de peso, atividade física, rastreio a cada 1-3 anos

CHECKLIST

NÃO ESQUECER

- ☐ Glicemia de jejum na 1a consulta; TOTG 75g entre 24-28 sem se jejum < 92
- ☐ 1 valor alterado no TOTG já fecha o diagnóstico de DG
- ☐ Dieta + exercício 1a linha; insulina se não atingir metas em 1-2 semanas
- ☐ Vigiar macrossomia (circunferência abdominal) e polidrâmnio
- ☐ Reclassificar no pós-parto (TOTG 6-12 sem) — DG é fator de risco para DM2

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA O PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO

- Gestante ____ semanas com diabetes gestacional (jejum ____ / TOTG ____).
- Controle: glicemias ____; em uso de dieta/exercício $\pm$ insulina ____ UI/kg/dia.
- Avaliação fetal: biometria/CA ____; líquido amniótico ____.
- Encaminhamento ao pré-natal de alto risco; reclassificar com TOTG 6-12 semanas pós-parto.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Gestante na 1a consulta com glicemia de jejum de 105 mg/dL. Qual o diagnóstico?

- A) Normal — repetir no 3o trimestre
- B) Diabetes gestacional (jejum 92-125 mg/dL na gestação)
- C) DM manifesto na gestação
- D) Hipoglicemia
- E) Intolerância à lactose

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

No TOTG 75g entre 24-28 semanas, quantos valores alterados são necessários para diagnosticar diabetes gestacional?

- A) Dois valores alterados
- B) Um único valor alterado (jejum ≥ 92 , 1h ≥ 180 ou 2h ≥ 153)
- C) Três valores alterados
- D) Nenhum; o diagnóstico é só pela HbA1c
- E) Apenas a glicemia casual

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o tratamento farmacológico padrão-ouro do diabetes gestacional?

- A) Metformina
- B) Insulina (não atravessa a placenta)
- C) Glibenclamida
- D) Inibidor de SGLT2
- E) Análogo de GLP-1

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual a principal complicação fetal do diabetes gestacional mal controlado?

- A) Restrição de crescimento
- B) Macrossomia (com risco de distócia de ombro e hipoglicemia neonatal)
- C) Anencefalia
- D) Oligodramnia grave
- E) Cardiopatia cianótica

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual a conduta no pós-parto da paciente com diabetes gestacional?

- A) Manter insulina indefinidamente
- B) Em geral suspender a insulina e reavaliar com TOTG 75g em 6-12 semanas (risco de DM2)
- C) Iniciar metformina para todas
- D) Nenhum seguimento é necessário
- E) Rastrear com HbA1c apenas após 5 anos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Glicemia de jejum entre 92 e 125 mg/dL na gestação diagnóstica diabetes gestacional. ≥ 126 seria DM manifesto; < 92 indica repetir com TOTG 75g entre 24-28 semanas.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Pelos critérios IADPSG/ADA, basta UM valor alterado no TOTG 75g (jejum ≥ 92 , 1h ≥ 180 ou 2h ≥ 153) para diagnosticar DG — diferente do antigo critério que exigia dois valores.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A insulina é o padrão-ouro do tratamento farmacológico da DG por não atravessar a placenta. A metformina é opção em casos selecionados, mas atravessa a placenta e ~30-40% precisam de insulina complementar.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A macrosomia (por hiperinsulinismo fetal) é a complicação fetal central, predispondo a distócia de ombro, tocotraumatismo e hipoglicemia neonatal.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

No pós-parto, suspende-se a insulina na maioria e reavalia-se a glicemia com TOTG 75g em 6-12 semanas, pois a DG é fator de risco para DM2 (30-70% em 10-20 anos).

SM24
Suporte ao Plantão Médico